EPICRISIS MÉDICA

HOSPITAL	:	HOSPITAL DE SAN CARLOS	N° EGRESO	:	86965
SERVICIO	:	GINECOLOGIA Y OBSTETRICIA HSC			
FECHA	:	2024-06-19 12:36:00			

DATOS DEL PACIENTE:

Nombre	: CLAUDIA ANDREA SOTO FUENTES			**RUN**	: 17.128.755-3
F.Nac	: 05-09-1988	**Edad**	: 35 AÑOS, 9 MESES	**Género**	: Femenino
Dirección	:			**Comuna**	: SAN CARLOS
Previsión	: SIN INFORMACION	**Teléfono**	: 0		
Fecha Ingreso	: 2024-06-18	**Fecha Egreso**	: 2024-06-19 12:36:00	**Causal**	: MEDICA
Condición	: VIVO	**Destino**	: DOMICILIO	**Derivación**	:

DIAGNOSTICO(S) INGRESO

1. K51.0-PANCOLITIS (CRONICA) ULCERATIVA

DIAGNOSTICO(S) EGRESO

1. Colitis Ulcerosa

DIAGNÓSTICOS CIE10

1. K50-K52-ENTERITIS Y COLITIS NO INFECCIOSAS (DIAGNÓSTICO PRINCIPAL)

COMENTARIO DE EVOLUCIÓN / COMPLICACIONES

Paciente ingresa con cuadro clínico de dolor abdominal localizado en hipocondrio derecho irradiado a epigastrio, acompañado de peak febril no cuantificado.
Ingresa con parámetros inflamatorios elevados PCR 152, con buena respuesta a ABT empírica con ceftriaxona y metronidazol , hoy asintomatica, sin nuevos peak febriles, se envia con hospitalizacion domiciliaria para completar terapia antibiotica con posterior control en Poli de Gastro para manejo y seguimiento de su patologia.

PLAN DE MANEJO:

Completar ABT durante 5 días en HODOM
Control en Poli de Gastro para continuar manejo de CU

INDICACIONES AL ALTA

1. Regimen de protección gastroduodenal rico en K
2. Reposo relativo
3. OMEPRAZOL COMPRIMIDO 20 MILIGRAMOS 1 comprimido cada 24 hrs. por 30 dias via ORAL
4. PARACETAMOL COMPRIMIDO 500 MILÍGRAMOS 2 comprimido cada 8 hrs. por 1 dias via ORAL
5. CEFTRIAXONA FRASCO 1 GRAMO 2 frasco cada 24 hrs. por 5 dias via ENDOVENOSA
6. METRONIDAZOL COMPRIMIDO 500 MILÍGRAMOS 1 comprimido cada 8 hrs. por 5 dias via ORAL
7. MESALAZINA 500 MG COMPRIMIDO UNIDAD 2 comprimido cada 12 hrs. por 30 dias via ORAL
8. AZATIOPRINA COMPRIMIDO 50 MILIGRAMOS 3 comprimido cada 24 hrs. por 30 dias via ORAL

EXÁMENES Y RESULTADOS

TAC de abd y pelvis C/C: pequeño foco de hipoatenuacion renal izq, pudiera estar en contexto de pielonefritis ?. Engrosamiento mural difuso del colon, que se encuentra en linea con diagnostico de referencia (colitis ulcerosa) . Quiste anexial izq e imagen sugerente de cuerpo lúteo der. de

considerar clínicamente necesario se sugiere evaluación dirigida . Colecistectomia.
Glicemia : 106 mg/dl 74 - 106
Creatinina : 0,50 * mg/dl 0,52 - 1,04
Clearence Calculado(MDRD) : 140,41 ml/min/1,73 | > 60
Proteina C Reactiva : 66,6 * mg/L < 10,0
Sodio (Na) : 141,00 mmol/L 135,00 - 145,00
Potasio (K) : 3,20 * mmol/L 3,50 - 5,50
Cloro (Cl) : 106,00 mmol/L 96,00 - 106,00
OC no inflam Uroc negativo

Claudia Paola Rivas Pacheco
MEDICO TRATANTE
27781954-6

JEFE SERVICIO